

Паспорт пилота 90 дней

Чистяков Е. В.

22.08.2026

- [Паспорт пилота «90 дней — один обед, одно отделение, одна неделя замера»](#)
 - [0. Ключевые параметры пилота](#)
 - [1. Три фазы пилота](#)
 - [ФАЗА 1. Замер \(дни 1–30\)](#)
 - [ФАЗА 2. Документы и обучение \(дни 31–60\)](#)
 - [ФАЗА 3. Пилот \(дни 61–90\)](#)
 - [2. Пять групп показателей пилота](#)
 - [Группа 1. Заполненность пищевых карт](#)
 - [Группа 2. Доля приёмов пищи, где выбор был реально доступен](#)
 - [Группа 3. Доля корректно исполненных заказов](#)
 - [Группа 4. Отказы, замены и пищевые отходы](#)
 - [Группа 5. События риска](#)
 - [3. Что не является KPI пилота](#)
 - [4. Остановка пилота \(стоп-критерии\)](#)
 - [5. После пилота: что делать с результатами](#)
 - [6. Согласование с учредителем \(обязательно\)](#)
 - [7. Документальный комплект пилота \(для проверяющего\)](#)

Паспорт пилота «90 дней — один обед, одно отделение, одна неделя замера»

Документ: методический инструмент для директора учреждения. **Версия:** 22.08.2026.

Назначение: управленческий документ, по которому запускается пилот вариативного питания в одном отделении на 90 дней. **Аудитория:** директор / заместитель по АХЧ / старшая медсестра / врач / завпроизводством.

Главное правило пилота. Это не внедрение нового меню. Это замер: сколько еды реально съедается, какие текстуры назначены, какие лекарства требуют осторожности, как организована помощь за столом, сколько выбрасывается, какие сигналы подаёт персонал. «% выбравших» — не KPI. Человек вправе выбрать стандартный вариант или не выбирать вовсе. Успех измеряется доступностью и исполнением осмысленного выбора, а не долей «выбравших».

0. Ключевые параметры пилота

Параметр	Значение	Обоснование
Длительность	90 дней	30 дней замер → 30 дней документов и обучения → 30 дней пилота
Отделение	1 (одно)	Модель Новосибирской области (S015, S016)
Размер отделения	20–35 жителей	Достаточно для статистики, не слишком много для ручного учёта

Параметр	Значение	Обоснование
Сложность	Лучше «сложное» (группа помощи, неговорящие)	Если получится у «сложного» — получится у всех
Смена	1 (одна)	Чтобы не размазать ответственность
Приём пищи	Обед (один)	Сначала один приём; расширение — после 60 дня
Смета	Без новых ставок и оборудования	Полный переход может потребовать (S017) — это второй шаг
Дата старта	Понедельник	Чтобы неделя совпала с календарной
Цель пилота	Измеримая гипотеза	«Улучшить потребление на 15 % и снизить отходы на 10 %» — иллюстративно; цель — своя цифра
Успех пилота	Не «% выбравших»	Доступность выбора + исполнение заказа + отсутствие событий риска

1. Три фазы пилота

ФАЗА 1. Замер (дни 1–30)

Цель: узнать фактическое состояние до любых изменений.

День	Действие	Ответственный	Документ	Контрольный показатель
1	Издать приказ о рабочей группе (5 фамилий + срок)	Директор	Приказ	5 фамилий, срок = дата+30
1	Посчитать сырьевую строку (расход / жители / дни)	Зам по АХЧ или завпроизводства	Таблица 1.1	Число в руб./чел./день
2	Запустить семидневный замер отходов	Завпроизводства	Журнал отходов	7 дней заполнены
2	Запустить замер тарелочных остатков	Старшая смена	Журнал остатков	7 дней × 3 приёма
3	Запустить замер ночного интервала	Старшая смена	Журнал интервалов	7 дней
5	Направить письмо-уведомление учредителю	Директор	Письмо	Отправлено / зарегистрировано
7	Собрать 5 чисел контингента по отделению	Зав. отделением + врач	Таблица 1.2	Все 5 чисел заполнены
10	Сформировать список риска дисфагии	Врач	Список на пост	Подписан врачом
14	Провести инструктаж смены (6 признаков раздела 10.3)	Старшая медсестра	Журнал инструктажа	100 % смены прошли

День	Действие	Ответственный	Документ	Контрольный показатель
21	Получить подписанную таблицу врача «лекарство × еда»	Врач	Таблица	На посту и в кухне
28	Сводный отчёт по замеру	Завпроизводства	Отчёт 1	Все 5 групп показателей заполнены
30	Решение: продолжать или корректировать	Рабочая группа	Протокол	Подписан 5 членами

Что НЕ делается в ФАЗЕ 1:

- не менять меню;
- не выбирать модель М1–М5;
- не выпускать пресс-релиз;
- не подключать совет жителей (он подключится на ФАЗЕ 2 при обсуждении пар эквивалентов).

ФАЗА 2. Документы и обучение (дни 31–60)

Цель: подготовить локальную нормативную базу и обучить персонал.

День	Действие	Ответственный	Документ	Контрольный показатель
31	Утвердить локальное «Положение об организации питания»	Директор	Положение	Подписано, зарегистрировано
33	Согласовать модель (М1–М5) с учредителем	Директор	Согласование	Получено письменное согласование
35	Сформировать 3–4 пары эквивалентов (завтрак/обед)	Диетсестра + врач	Таблица пар	Подписана врачом
38	Провести обучение смены (3 занятия по 40 мин)	Зам по АХЧ + врач	Журнал обучения	100 % смены, IDDSI-тест
42	Ввести журнал заказа блюд	Старшая смена	Журнал	Форма утверждена
45	Ввести журнал отказов с триггерами	Старшая смена + врач	Журнал	Три отказа → запись → врач в день
48	Обучить повара тесту IDDSI (вилка, ложка, наклон)	Завпроизводства	Журнал	Повар сдал практический тест
52	Подключить совет жителей (если есть) к обсуждению пар	Старшая по отделению	Протокол совета	Подписан
55	Провести пробный запуск на одном обеде (без публикации)	Завпроизводства	Акт	1 обед без сбоев

День	Действие	Ответственный	Документ	Контрольный показатель
60	Сводный отчёт по документам и обучению	Зам по АХЧ	Отчёт 2	Все позиции заполнены

Что НЕ делается в ФАЗЕ 2:

- не публиковать пресс-релиз;
- не масштабировать на другие отделения;
- не менять закупку.

ФАЗА 3. Пилот (дни 61–90)

Цель: запустить выбор и собрать данные.

День	Действие	Ответственный	Документ	Контрольный показатель
61	Старт пилота (понедельник)	Директор	Акт	Объявление смене и жителям
61–90	Ежедневно: журнал заказа, журнал отказов, остатки	Старшая смены	Журналы	Заполняются ежедневно
75	Промежуточный контроль (15 дней)	Рабочая группа	Протокол	5 групп показателей
80	Корректировка (если нужно)	Завпроизводства + врач	Протокол	Что изменили
90	Итоговый замер (такой же, как день 7)	Завпроизводства	Отчёт 3	5 групп показателей
95	Решение о корректировке или масштабировании	Директор	Решение	Подписано, в журнал

2. Пять групп показателей пилота

Группа 1. Заполненность пищевых карт

Что измеряет: качество клинической документации по питанию.

Поле	Числитель	Знаменатель	Источник данных	Периодичность	Ответственный	Риск интерпретации
Доля жителей с заполненной пищевой картой	Число жителей с заполненной картой	Общее число жителей в пилотном отделении	Пищевые карты (приложение 3)	1 раз в 30 дней	Старшая медсестра	«100 % карт» ≠ «100 % правильно заполненных»; нужна проверка качества

Группа 2. Доля приёмов пищи, где выбор был реально доступен

Что измеряет: доступность выбора, а не «% выбравших».

Поле	Числитель	Знаменатель	Источник	Периодичность	Ответственный	Риск
Приёмы с реально доступным выбором	Число приёмов (обед), когда жителям предлагались 2 варианта	Общее число обедов в периоде	Журнал заказа	Ежедневно	Старшая смены	«100 % обедов» ≠ «100 % жителей выбрали»; человек вправе выбрать стандарт

Группа 3. Доля корректно исполненных заказов

Что измеряет: качество исполнения.

Поле	Числитель	Знаменатель	Источник	Периодичность	Ответственный	Риск
Корректно исполненные заказы	Число заказов, по которым подано именно то, что заказано (включая текстуру)	Общее число заказов	Журнал заказа + акт приёма	Ежедневно	Завпроизводства	«100 %» — это не цель; цель — снизить число ошибок; абсолютные 100 % редки

Группа 4. Отказы, замены и пищевые отходы

Что измеряет: качество планирования.

Поле	Числитель	Знаменатель	Источник	Периодичность	Ответственный	Риск
Доля приёмов с отказом ≥50 %	Число приёмов, где ≥50 % порции осталось	Общее число приёмов	Журнал остатков	Ежедневно	Старшая смены	«0 % отказов» нереалистично; цель — выявить аутсайдеров и заменить их парами
Кухонные остатки (гр/чел./день)	Масса пищевых отходов кухни	Число жителей × дни	Журнал отходов	Ежедневно	Завпроизводства	«Минимум» — недостижим; цель — стабилизация
Замены (пар эквивалентов)	Число замен по таблице пар	Общее число заказов	Журнал замен	Ежедневно	Старшая смены	Большое число замен ≠ плохо, если исполняется

Группа 5. События риска

Что измеряет: безопасность.

Поле	Числитель	Знаменатель	Источник	Периодичность	Ответственный	Риск
Аспирационные пневмонии	Число пневмоний	Число жителей ×	Мед. документация	1 раз в 30 дней	Врач	«0 пневмоний» за 90 дней не

Поле	Числитель	Знаменатель	Источник	Периодичность	Ответственный	Риск
	за период	дни				гарантировано; цель — отсутствие роста
Падения	Число падений в столовой	—	Журнал	Ежедневно	Старшая смены	Абсолютные цифры; сравнение с предыдущим кварталом
Агрессивные инциденты за столом	Число инцидентов	—	Журнал	Ежедневно	Старшая смены	Сравнение с предыдущим периодом
Гиперфагические эпизоды	Число эпизодов	—	Журнал	Ежедневно	Врач + смена	Только для жителей на весогенных препаратах
Случаи отказа от еды ≥ 3 дней подряд	Число случаев	—	Журнал отказов	Ежедневно	Врач	Каждый случай → врач в тот же день

3. Что не является KPI пилота

«Метрика»	Почему не KPI
«% жителей, выбравших альтернативу»	Человек вправе выбрать стандарт или не выбирать вовсе
«Число поданных жалоб»	Жалоба $\neq$ плохой результат; жалоба — обратная связь
«Объём вложенных денег»	Не KPI; KPI — отходы и потребление
«Скорость раздачи»	Скорость — параметр безопасности, а не KPI успеха
«Число внедрённых пар эквивалентов»	Много пар $\neq$ хорошо; важно качество пар

4. Остановка пилота (стоп-критерии)

Пилот **останавливается** (не масштабируется, не продлевается) при следующих событиях:

1. **Рост пневмоний** в пилотном отделении ≥ 30 % по сравнению с предыдущим кварталом.
2. **Падение со смертельным исходом** в столовой пилотного отделения.
3. **Жалоба жителя / родственника** в прокуратуру на нарушение при пилоте.
4. **Приказ учредителя** о приостановке.
5. **Отзыв согласия учредителя.**
6. **Отсутствие врача** на посту (невозможность исполнить границу 4.0).

Решение о возобновлении принимается директором после устранения причины остановки и согласования с учредителем.

5. После пилота: что делать с результатами

Результат	Решение
4 из 5 групп показателей в норме	Масштабирование на 1–2 отделения; новая фаза обучения
3 из 5 в норме	Корректировка пар, дополнительный инструктаж; повторный пилот 60 дней
2 из 5 в норме	Остановка; анализ причин; новый замер
1 или 0 в норме	Смена подхода; смена модели (M1 ↔ M2); обязательная ревизия медицинской рамки

Главное правило. Пилот — **измеримая гипотеза**, а не обещание успеха. «Не получилось» — это тоже результат, который говорит, что именно в вашем учреждении нужно менять.

6. Согласование с учредителем (обязательно)

Письмо-уведомление (1 страница) должно содержать:

1. **Обоснование** — ссылки на СанПиН 3590-20 п. 7.1.11 (до 31.08.2026) и СанПиН 4282-26 п. 56(11) (с 01.09.2026); ссылки на 442-ФЗ ст. 9 (уважительное и гуманное отношение), ст. 16 (ИППСУ); 3185-1 ст. 5 ч. 2 (право на гуманное отношение).
2. **Ссылка на публичные практики** — Успенский ПНИ (S016), Болотнинский ПНИ (S015), Усть-Илимский ДСО (S017), Иркутская область (S018), опыт Серафимовского (S030, S035 — **локальный приказ**, не руководство).
3. **Срок пилота** — 90 дней, начиная с [дата].
4. **Точка пилота** — одно отделение, 20–35 жителей, один обед.
5. **Про́сьба** — согласовать или подтвердить уведомительный порядок.
6. **Подпись** директора.

Шаблон — 08_версии/10_правовые_развилки.md (будет создан в рамках этапа 10).

7. Документальный комплект пилота (для проверяющего)

1. **Приказ о рабочей группе** (день 1).
2. **Письмо-уведомление учредителю** (день 5) + ответ.
3. **Пищевые карты** (постоянно, на каждого жителя).
4. **Журнал отходов** (дни 2–90).
5. **Журнал остатков** (дни 2–90).
6. **Журнал ночного интервала** (дни 3–30).
7. **Таблица врача «лекарство × еда»** (на посту, день 21+).
8. **Список риска дисфагии** (на посту, день 10+).
9. **Пары эквивалентов** (подписанные врачом, день 35+).
10. **Журнал заказа** (дни 42–90).
11. **Журнал отказов** (дни 45–90).
12. **Журнал обучения** (дни 14, 38, 48).
13. **Отчёт 1** (замер, день 28).
14. **Отчёт 2** (документы и обучение, день 60).
15. **Отчёт 3** (пилот, день 90).
16. **Протокол итогового решения** (день 95).

Итого 16 документов. Это минимум для ответа проверяющему. Все формы — в 08_версии/09_кейсы.md (создаётся в рамках этапа 10) и в 09_инструменты/форма_базового_замера.md .

Дата: 22.08.2026. **Применяется:** директором учреждения после согласования с учредителем. **Правовая основа:** 442-ФЗ, 3185-1, СанПиН 3590-20 (до 31.08.2026) / СанПиН 4282-26 (с 01.09.2026). **Дисклеймер:** это проект локальной формы, не нормативный документ; требует адаптации к конкретному учреждению.